

Fecha Última Actualización: 18-03-2022 10:12:02

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Jeanette Paola Blanco Urzúa
Edad : 50a 2m 19d
Dirección : Calle Turquesa 10962

Rut : 12.178.052-6
Fecha Nacto: 26/12/1971
Comuna : La Florida

N° Archivo : 9511774
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 3506 1433

N° Epicrisis
298379

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim

Fecha Ingreso : 16/02/2022 03:40

Días Estadía : 29

Unidad de Egreso : Medicina Básica (2do Piso)

Fecha Egreso : 17/03/2022 10:03

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

disnea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Nombre: Jeanette Blanco Urzúa
RUT: 12178052-6
Edad: 50 años
FI CASR: 16/02/22
FI UTIM: 16/02/22
FI UCI: 17/02/22
FI UTIM: 08/03/22
FI Sala: 09/03/22

Antecedentes:

- Mórbitos: Sd. Wolff Parkinson White, Asma
- Quirúrgicos: 2010 laparotomía por herida de arma blanca en abdomen, 2013 reparación de tendones flexores (índice y medio D).
- Fármacos: Carvedilol 12.5 mg/día, Brexotide 2 puff cada 12 h, Berodual, Salbutamol SOS.
- Alergias: (-)
- Hábitos: TBQ (+) IPA 25 en vías de suspensión, OH (-), PBC suspendido. Exposición en la infancia a contaminantes (industrias, papelería, molino)
- Hospitalizaciones: : 2020 neumonía y crisis asmática.
- Vacunas: COVID 1 dosis.

Historia de ingreso:

Paciente con antecedentes descritos, consulta por cuadro iniciado el 13/02 con sensación febril no cuantificada, dolor torácico tipo puntada de costado, tos seca y disnea de mínimos esfuerzos, sin mialgias, rinorrea, sangrado, compromiso de conciencia u otros síntomas, sin contacto con casos conocidos COVID (+). Se describe en UEA en RCG, deshidratada, bien perfundida, taquipneica, sat 95% con MV 4 L, sin UMA, con sibilancias difusas, crépitos finos bibasales, sin edema. Al laboratorio inicial destaca GB 10.590, RAL 2.200, láctico 19, TUS 10, LDH 411, PCR 230. AngioTAC sin TEP, compatible con neumonía COVID pero PCR COVID (-), panel viral (-). Se maneja con corticoides, BD, O2 y sulfato de magnesio con buena respuesta. Ingresa a UTIM, evoluciona rápidamente crisis obstructiva que no responde a broncodilatadores ni uso de corticoides, con deterioro de mecánica ventilatoria intubándose el 17/02.

Fecha Epicrisis : 18/03/2022 10:12

Página 1 de 4

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 13:30

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 18-03-2022 10:12:02

Página 2 de 4

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO

- Crisis asmática
- Neumonía COVID
- FIS 13/02 (+3)
- Antecedentes: Asma, Sd. Wolff Parkinson White.

EVOLUCIÓN

Hemodinamia: Post sedación evoluciona con TPSV y requerimientos de DVA con NAD hasta 0.2 mcg/Kg/min, se cardiovierte con 100J con buena respuesta, con descenso de DVA a dosis mínimas. Manejo de WPW con bisoprolol. Con nuevos requerimientos de DVA en relación a último episodio de estridor, suspendido precozmente. Evoluciona favorablemente. Con buen control de patología de base.

Respiratorio: Con requerimientos de VMI por SDR + crisis obstructiva grave. Dado este último recibe BIC de ketamina para promover broncodilatación. Requirió BNM (17/02-23/02) y prono (17/02-22/02). Completó 10 días de dexametasona por protocolo Recovery. Se extuba el 28/02 saliendo a CNAF pero evoluciona con estridor y deterioro de la mecánica ventilatoria en 2 oportunidades, que no respondió a manejo con corticoides, broncodilatadores o nebulización con adrenalina por lo que se reintuba el mismo día. Se maneja con dosis altas de corticoides logrando extubación el 04/03 con salida a CNAF. Presenta nuevos episodios de estridor de difícil manejo con BIPAP + corticoides + NBZ con adrenalina + antihistamínicos, último 07/03 con hipotensión asociada por lo que se iniciaron DVA, suspendido precozmente. Sin requerimientos de oxígeno desde el 08/03. Sin nuevos episodios de estridor. Actualmente con Bromuro de ipatropio, salbutamol y budesonida.

ORL: posterior a extubación cursa con estridor. Evaluada por ORL, quienes observan por NFC parálisis de cuerdas vocales y laringitis posterior. TAC de Cuello sólo informa cambios inflamatorio maxilares izq. Se discute con ORL y se indica control ambulatorio. Mantener IBP por 8 semanas.

Infeccioso: Presenta bacteriuria asintomática por E. coli + NAVM por SAMS manejado con cloxacilina por 8 días. Posteriormente presenta NAVM por neumococo y SAMS. Punta de CVC (+) para S. haemolyticus + Klebsiella oxytoca MS, con hemocultivos periféricos negativos concomitantes. Se inicia tratamiento con ampicilina/sulbactam, completando 7 días. Presenta nuevo episodio de fiebre y alza de parámetros inflamatorios el 11/03, se pancultivó y se inició Imipenem empírico, con respuesta favorable, parámetros inflamatorios a la baja. Se rescata resultado de cultivo traqueal (+) para Klebsiella pneumoniae multisensible. Se ajusta tratamiento a Ampicilina sulbactam, completando 5 días de tratamiento en total. Parámetros inflamatorios a la baja.

Endocrinológico: Paciente con dosis altas de corticoides por más de 2 semanas en relación a protocolo recovery y luego para manejo de estridor laríngeo, dado posible supresión del eje se inició decalaje con prednisona.

Rehabilitación:

- Motor: logra marcha asistida, continuar rehabilitación con KNT.
- FNA: Rehabilitación por FNA, inicia alimentación VO el 14/03. Actualmente con régimen blando sin granos.
- Delirium: Impresiona conectada, de momento no es conflicto. Mantengo antipsicóticos. Titular a suspende en UHD.

DIAGNÓSTICOS ACTUALES

1. Crisis asmática resuelta
Obs NAC COVID (imagen compatible, PCR ingreso (-))
IOT 17/02-28-02 y 28/02- 04/03
BNM 17/02-23/02, prono 17/02-22/02.
2. Traqueobronquitis por Klebsiella pneumoniae multisensible
3. Estridor laríngeo de difícil manejo, resuelto
4. TPSV con necesidad de CVE
5. NAVM por neumococo resuelto
6. Disfagia del paciente crítico en tratamiento
7. Miopatía del paciente crítico
8. Delirium
9. NAVM por SAMS tratada
10. Antecedentes: Asma, sd. WPW

Fecha Última Actualización: 18-03-2022 10:12:02

Página 3 de 4

Diagnóstico de Egreso

Neumonía Adquirida En La Comunidad (Nac) - Obs Covid
Neumonía Intrahospitalaria No Asociada A Ventilación Mecánica -
Insuficiencia Respiratoria Aguda - Estridor Laringeo
Asma - 1. Insuficiencia Respiratoria Aguda Resuelta
1. Crisis Asmática
2. Obs Nac Covid (Imagen Compatible, Pcr Ingreso (-))
3. lot 17/02-28-02 Y 28/02- 04/03
4. Bnm 17/02-23/02, Prono 17/02-22/02.
2. Traqueobronquitis Por Klebsiella Pneumoniae Multisensible
3. Estridor Laríngeo De Difícil Manejo, Resuelto
4. Tpsv Con Necesidad De Cve
5. Navm Por Neumococo Resuelto
6. Disfagia Del Paciente Crítico En Tratamiento
7. Miopatía Del Paciente Crítico
8. Delirium
9. Navm Por Sams Tratada
10. Antecedentes: Asma, Sd. Wpw

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J: NO

Paciente en buenas condiciones generales, cooperadora. En condiciones de continuar rehabilitación fuera del hospital.

Plan Post Alta

Indicaciones hospitalización domiciliaria
Neurorrehabilitación (fonoaudiológica, kinesioterapia motora y respiratoria)
reposo relativo, activar.
Régimen blando sin grandos + líquidos claros (sorbos únicos). Progresar según evolución.

Paracetamol 1 g cada 8 h VO
Bisoprolol 5 mg por VO
Bromuro de ipatropio 2 puff c/8 hrs por AEC
Salbutamol 2 puff c/6-8 hrs por AEC según necesidad
Budesonida 2 puff c/12 hs por AEC
Prednisona 5 mg al día por 5 días, luego suspender.
Risperidona cada 12 horas: 0.5mg - 1 mg VO por 1 semana, luego 1mg PM por 1 semanas y suspender.

Control con broncopulmonar CDT tras alta UHD. Pedir hora con epicrisis.
Control con cardiología para seguimiento de patología de base. Pedir hora en CDt con epicrisis.
Control con otorrinolaringología para seguimiento de parálisis de cuerdas vocales derechas. Al alta, pedir hora con epicrisis en CDT

Indicaciones

Tipo de Reposo : Blando + Líquidos Claros, Progresar

Régimen Alimentario : Relativo, Activar

Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 18/03/2022 10:12

Página 3 de 4



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 18-03-2022 10:12:02

Página 4 de 4

INTERNO

Becado/Residente

Alberto Anselmo Albornoza Mora

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 18/03/2022 10:12

Página 4 de 4

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 13:30

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar